

OK

56 anos.

90kg

VANIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MAGALHÃES			
SINTOMAS / QUEIXAS	Dor de cabeça / Ansiedade / HAS / Tireoide / Ins.		
MEDICAMENTOS	Eltrox 200mg / Parz / Diaguo / Zestale		
pram (4anos) /			
HORA QUE DORME:	23	HORA QUE ACORDA:	8h
BANHEIRO	1 à 2x	IAH = 90,5	
TIPO DE RESPIRAÇÃO		SpO2 77%	
PRÁTICA EXERCÍCIO	não faz		
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFE: 5		ALMOÇO: 5	LANCHE: 5 JANTAR: —
IDADE: 56a.	PESO: 90	IAH: 90,5	MALLAMPATI: 3 SPO2:
03/01 - menopausa - 45 anos.			
23 IAH = 54,5 → SpO2 84%			
26/01 P = 7,0			
23 IAH = 1,8 e/ev			
m. de uso: 8:30'			
Pressão art. ainda n. alt.			
Melhora da dor de cabeça / acorda (+) vezes.			
fua			
24/05/24 P = 7,0 cmH2O			
IAH = 2,1 e/ev			
m. de uso: 8h e 16m			
Somente verificamos aparelho Natasha			
16/07/24 P = 6,2 cmH2O			
IAH = 3,2 e/ev			
m. de uso: 7h e 16'			
Fuga = 3,3 lpm.			
fua.			

Nicole Martuscelli de Almeida

Médica

CRM-MG: 62.814

Vania da Conceição Ribeiro
Magalhães

Encaminho paciente acima
referida para adaptação de
CPAP.

Sugiro CPAP automático
com umidificador pressão
14 cmH₂O máscara oronasal

Atenciosamente,

Dra. Nicole Martuscelli de Almeida
CRM-MG 62814
CONTROLE 9611568

27/12/2022

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: VANIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MAGALHAES			
Sexo: F	Idade: 55 anos	Peso: 90 Kg	Altura: 1,70 m
IMC: 31,1	Data do Exame: 22/08/2022	Exame: 11995_01	
Médico solicitante: DRA EUGENIA			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:13:16 horas e encerrado às 06:02:11 horas, com latência para o sono de 15 minutos e latência para o sono REM de 335 minutos. O tempo total de sono foi de 376,5 minutos, com eficiência do sono de 91,7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,1%	Até 5%
Estágio 2	94,2%	45 - 55%
Estágio 3	1,5%	> 15%
Sono REM	3,3%	20 - 25%
Eficiência do sono	91,7%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 18,5 minutos ocorreram **621 despertares (índice de 99,0 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 58 bpm, a maior de 68 bpm e a menor de 54 bpm. Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 568 eventos respiratórios, sendo 0 central, 568 obstrutivos e 0 misto. Sendo 533 apnéias, 35 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 90,5/hora**, sendo 84,9 apnéia/hora e 5,6 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 22,8 e a duração máxima de 41,8.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 96,0/hora, sendo 91,2 apnéia/hora e 4,8 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%**, sendo a saturação média de 92%, a maior de 99% e a mínima de 77%, permanecendo 90,0 minutos (21,9%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,2 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 571 dessaturações. Índice de dessaturações: 91,8/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 96,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 92,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264

Nome: VANIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MAGALHAES

Data de Nascimento: 5-12-1966

IMC: 31,14

Sexo: Feminino

Data do exame: 16-11-2022

Peso: 90 kg

Altura: 1,70 m

Médico: DRA. NICOLE MARTUSCELLI DE

ALMEIDA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-11-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletroculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 417,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 38,5 e 83,0 minutos. O tempo total de sono foi de 317,0 min, eficiência de 75,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,7%; estágio N2: 63,7%; estágio N3: 13,4%; sono REM: 20,2%. O índice de despertares foi de 48,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 54,5/hora, sendo 33 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 255 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 84%, permanecendo 4,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 62 bpm e NREM de 50 - 73 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (23,8/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 14,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Márcio Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157